MAPA MENTAL DE CONSULTA RÁPIDA · PLANTÃO

CUIDADOS COM A VIA AÉREA ARTIFICIAL

Tubo orotraqueal e traqueostomia — checagem à beira do leito (paciente adulto)

VERIFICAÇÃO E FIXAÇÃO

pré-requisitos

- Tubo centralizado na boca — evita úlcera de pressão no lábio
- Comissura labial: marcar sempre no **dente**, nunca no fixador
- Confirmar posição por **raio-X** + **ausculta** pulmonar
- Fixar sempre **em dupla**, para segurança do procedimento
- Registrar a comissura em **toda** evolução (perceber se desposicionou)
- Traqueostomia: cadarço justo + **uma** gaze só (absorve secreção)

METAS E PARÂMETROS

valores de referência

- Pressão do cuff: **20–30 cmH_2O**
- Usar sempre a **menor pressão** que veda a via aérea
- Hiperinsuflação → isquemia → risco de **traqueomalácia**
- Higiene da endocânula: **1 a 3x/dia**, conforme necessidade

FLUXO: PROGRESSÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA

algoritmo principal

Plástica c/ cuff — Portex
sem endocânula · VM prolongada

▼

Shiley c/ endocânula branca
sem fenestra · enquanto há risco de aspiração

▼

Shiley c/ endocânula fenestrada (verde)
permite fonação · cuff já desinsuflado por mais tempo

▼

Cânula **metálica** — sem cuff
paciente já depende da via aérea superior

▼

Teste de oclusão + bem >24h → Decanulação

ASPIRAÇÃO, FILTROS E CUIDADOS ESPECIAIS

técnica

- Sonda até o paciente **tossir** — evita trauma na via aérea
- Sistemas fechados de tamanhos diferentes (tubo x traqueo)
- 2 dispositivos (lavagem da sonda / aerossol) — fechar após o uso
- Filtro do circuito sempre voltado **para cima**
- HME (aquece/umidifica) x filtro de barreira (exalatório)
- Cultura: coletor ("bronquinho") — pode ser direto no sistema fechado
- Guedel: medir do canto da boca ao lóbulo; inserir virada para cima até bater no palato duro, girando

SINAIS DE ALERTA

fique atento

- Cuff hiperinsuflado → isquemia → **traqueomalácia**
- Excesso de gaze na fixação → exteriorização da cânula
- Filtro trocado de posição → prejuízo ao paciente/ventilador
- Secreção acumulada no filtro → aumenta resistência

NUNCA FAÇA

- Prender a linha do cuff ou sondas junto ao fixador
- Usar excesso de gaze na fixação da traqueostomia
- Aspirar usando a endocânula **fenestrada (verde)** — risco de lesão
- Conectar a nebulização direto na cânula, sem saída expiratória — **risco de morte**
- Decanular sem testar oclusão e confirmar boa tolerância